

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (12)

병원 화재진압요령·구급대책 (본문 287~288p)

핵심 개념

병원 환자에게 방수하면 쇼크·냉기로 악영향을 줄 수 있어 옴호방수에 특히 주의한다. 대량환자 발생 시 현장응급의료소를 설치하며, 구급차 진입·퇴로는 일방통행으로 설치한다.

3) 화재진압 요령

병원 화재진압 요령:

병원 화재진압요령 8가지

- 1) 선착대는 경비원·당직원으로부터 정확한 화점·요구조자 정보 수집
- 2) 화재 초기·중기는 적극적으로 내부진입 수단 마련해 관창 전개
- 3) 병원 설치 소화설비를 효과적으로 활용
- 4) 자위소방대가 있으면 소방대 도착 후에도 계속 지원협력하게 함
- 5) 연소확대 예상 시 관창배치는 제1을 화점층, 제2를 화점상층 목표로 배치
- 6) 방수는 식사·분무를 효과적으로 병행해 소화
- 7) 환자에게 방수하면 쇼크 또는 냉기로 악영향을 줄 수 있어 옴호방수는 주의 요함
- 8) 화재진압계획이 있는 소방대상물은 그 계획을 참고해 활동

시험 포인트

병원 옴호방수는 일반 건물과 달리 "환자 쇼크·냉기 악영향"이라는 특수 위험이 있어 신중해야 한다는 점 — 다른 시설의 옴호방수와 목적은 같지만 대상(환자)의 특수성을 고려해야 함.

4) 구급대책

병원화재의 구급대책:

구급대책 6가지

- 1) 대량환자 예상 시 신속히 현장응급의료소 설치
- 2) 현장응급의료소는 구급차 진입·퇴로 용이한 장소, 진입·퇴로를 일방통행으로 설치. 후착 소방차는 구급차 진입·퇴로에 장애 안 되게 배치 통제
- 3) 병원분산배치표 참고해 환자를 분산 이송, 주요 병원에는 미리 연락
- 4) 환자 증상 평가, 쇼크 방지 위해 보온조치
- 5) 필요시 의사 등 전문 의료요원 요청
- 6) 부상자·요구조자 인원·성명·성별·부상정도·수용병원 조사 전담대원 지정, 정확하고 종합적인 정보처리. 현장응급의료소는 관계자 외 출입통제 소방통제선 설치

시험 포인트

현장응급의료소의 진입·퇴로를 "일방통행"으로 설치한다는 구체적 운영원칙 — 구급차 병목현상을 막기 위한 조치.